

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	胸腔物理治療 Chest Physical Therapy				
編號	A31000-Q05-W-B12	制定者	CCU 蔡澄毓	公布日期	89 年 01 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	113 年 07 月 02 日
版本/總頁數	第 3.5 版/7 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 06 月 16 日

一、目的

護理人員能正確操作胸腔物理治療技術。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）技術目的

幫助病人採取不同的姿勢以藉由地心引力（重力）原理，使肺部的分泌物易於排出，且可：

1. 預防肺擴張不全。
2. 防止過多痰液的囤積。
3. 促進痰液的鬆動與排除。
4. 增進或提升更有效的呼吸型態。
5. 促進換氣之效用及均勻分佈。
6. 增進呼吸肌肉的耐力。
7. 改善心肺功能及其耐受力。

（二）用物準備

1. 治療盤。
2. 若有開立醫囑做痰液培養則需準備痰液收集盒。
3. 感染可燃性塑膠袋。

主題名稱	胸腔物理治療	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B12	版本	第 3.5 版	頁碼/總頁數	2/7

4. 衛生紙。
5. 枕頭。
6. 拍痰杯。
7. 抽痰設備。
8. 聽診器。
9. 震痰器（需要時）。

（三）步驟及要點說明

步驟	說明
1.洗手。	
2.姿位引流前準備事項：	
(1)以聽診器聽診呼吸音。	
(2)向病人及家屬解釋姿位引流的目的。	
(3)向病人及家屬教導有效深呼吸及咳嗽。	
(4)詢問前次用餐時間。	在飯前 1 小時或飯後 2~3 小時或睡前執行，以防噁心、嘔吐及吸入，視病人情形每天做 2~4 次為宜，不可穿緊身衣。
(5)依聽診及 X 光片，決定引流的姿勢及部位。	
(6)測量病人的 T.P.R.及 BP。	
(7)痰液收集器、衛生紙置於病人旁。	
(8)檢查床旁備抽痰系統。	
3.姿位引流程序：	
(1)視情況協助病人臥於正確位置，準備引流。	要隨時觀察病人的呼吸狀況、皮膚顏色及脈搏，必要時可以使用氧氣。
A.肺上葉尖節(apical segment)： 採半坐臥，以枕頭靠背，使背部彎曲成 30 度叩擊在兩側上胸部乳頭以上近肩膀位置。	
B.肺上葉前節(anterior segment)： 採仰臥平躺，將枕頭置於膝蓋下，使膝蓋呈彎曲狀，背部平貼於床，叩擊在前胸部乳頭與鎖骨間之胸壁上。	
C.肺上葉後節(posterior segment)： 採反向坐於椅子上跨坐，前胸靠著椅背，以枕頭置於胸前與椅背之間，使身體向前傾約 30 度，叩擊在兩側背上方肩胛窩處。	

主題名稱	胸腔物理治療	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B12	版本	第 3.5 版	頁碼/總頁數	3/7

步驟	說明
D.肺上葉舌節(lingular segment)： 將床尾上升 15 度或床腳提高 35 公分，病人以右側躺後身體再向左後側旋轉 1/4 圈，以枕頭墊在左側臀及左肩下，左膝彎曲，叩擊左側乳頭下部位。	
E.右肺中葉側(lateral)節及中(medial)節： 將床尾上升 15 度或床腳提高 35 公分，病人以左側躺後身體再向右後側旋轉 1/4 圈，以枕頭墊在右側臀及右肩下，右膝彎曲，叩擊右側乳頭下部位。	
F.肺下葉上節(superior segment)： 病人俯臥於床上，並以枕頭墊於腹部下，使臀部高起，使下胸部與床面水平線呈 15 - 30 度，叩擊於兩側背部肩胛骨角附近。	
G.肺下葉前基底節(anterior basal segment)： 將床尾上升 30 度或床腳提高 45 公分，採仰臥平躺，將枕頭置於膝蓋下，使膝蓋呈彎曲狀，背部平貼於床，叩擊在乳頭下方。	
H.肺下葉側基底節(lateral basal segment)： 將床尾上升 30 度或床腳提高 45 公分，若為右側疾病病人以左側躺，右腳彎曲，大腿間夾枕頭，叩擊下端肋骨之最高部位。若為左側疾病，則躺的方向相反。	
I.肺下葉後基底節(posterior basal segment)： 將床尾上升 30 度或床腳提高 45 公分，病人俯臥於床上，枕頭墊在胸部及臀部下，叩擊最下端肋骨與脊椎間之下背部。	
J.叩擊： 將手握成杯狀或使用拍痰杯，保持手指彎曲，叩擊時肩及肘關節放鬆，腕關節隨叩擊動作做屈曲及伸直，每一治療部位連續 3-5 分鐘，叩擊頻率為 3-5 次/秒，叩擊聲音應為空洞聲。	避免叩擊胸骨、脊椎、肝、腎、脾及乳房等臟器部位。
K.震顫： 將一隻手置於病人的胸壁上，另一隻手重疊其上，手肘伸直，由肩而至手掌，用整隻手的力量去推擠胸壁，當病人吐氣時，手快速的左右顫動或使用震痰器，可連續做 5-10 次或治療 2-5 分鐘，每次 8 到 20 秒。	
L.協助病人作深呼吸及咳嗽，若病人無能力自咳，可藉由抽痰器抽吸。	
M.引流完時，協助病人採舒適臥位。	

主題名稱	胸腔物理治療	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B12	版本	第 3.5 版	頁碼/總頁數	4/7

步驟	說明
N.記錄引流時間、引流分泌物之質與量、有無不適的症狀。	
4.注意事項：	
(1)姿位引流前 15 分鐘，需要時依醫囑可先給予支氣管擴張劑、化痰劑。	
(2)飯前 1 小時或餐後 2 小時內，避免做治療。	
(3)引流時，先引流上葉，再引流下葉，姿位引流可維持 5-15 分鐘再逐漸延長 15-20 分鐘。	
(4)當聽不到任何痰聲，引流不出分泌物時，或病人咳嗽形成乾咳、沒有痰液時，可停止姿位引流。	
(5)禁忌：患有心臟病、心肌梗塞、顱內升高的病人不適合做姿位引流。	

(四) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 于博苒、胡文郁、胡月娟、周守民、黃翠媛、吳韻淑...李惠玲等(2016)·呼吸系統疾病之護理·於劉雪娥總校閱，成人內外科護理上冊(1003-1006 頁)·台北市:華杏。
- (二) 余怡珍、鄭幸宜、王玉珍、張怡雅、陳亭儒、高月梅...劉碧霞等(2013)·背部護理·新編基本護理學(四版，106-111 頁)·新北市：新文京。
- (三) 林王美園(2011)·呼吸的需要·照顧服務員實用工作指南(二版，58-59 頁)·台北市：華杏。

主題名稱	胸腔物理治療	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B12	版本	第 3.5 版	頁碼/總頁數	5/7

(四) 蔡玲君、張凱喬、柯雅妍、游秀珍、林玫君、游金靖...藍麗美等(2010)・呼吸系統護理技術•新編內外科護理技術・台中市：華格那。

七、附件

(略)

主題名稱	胸腔物理治療	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B12	版本	第 3.5 版	頁碼/總頁數	6/7

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
89.01.31	1.0	新制定。	89 年 01 月 31 日護理部技術標準委員會通過。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
100.08.03	2.1	修改說明內容。	100 年 08 月 03 日護理部技術標準委員會通過。
101.06.06	2.2	修改說明內容修辭。	101 年 06 月 06 日護理部技術標準委員會通過。
102.02.20	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
103.06.30	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.06.18	3.1	更新第六項參考資料。	104 年 06 月 18 日護理部技術標準委員會通過。
105.06.21	3.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
106.06.19	3.2	1. 第三項第(三)目增修部份說內容。 2. 更新第六項參考資料。	106 年 06 月 19 日護理部技術標準委員會通過。
107.06.25	3.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
108.06.17	3.3	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第四日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 06 月 17 日護理技術組會議通過；108 年 07 月 17 日護理長會議通過；108 年 07 月 23 日督導會議通過公布。
109.06.15	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

主題名稱	胸腔物理治療	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B12	版本	第 3.5 版	頁碼/總頁數	7/7

修正日期	版本	修正說明	備註
110.09.23	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.08.02	3.4	第三項第三目步驟 3.說明內容修訂。	111 年 06 月 20 日護理技術組會議通過；111 年 07 月 13 日護理長會議通過；111 年 08 月 02 日督導會議通過公布。
112.07.03	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.07.02	3.5	第三項第三目步驟及要點說明 3.(1)-G 說明內容修訂。	113 年 06 月 17 日護理技術組會議通過；113 年 07 月 02 日督導會議通過公布。
114.06.16	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	